

AAP pour une procédure programmée

Introduction, méthodologie & légende



Champ : gestion péri-procédurale d'un traitement antiplaquettaire (AAP) oral au long cours — aspirine, clopidogrel, prasugrel, ticagrélor — chez un patient devant bénéficier d'une **procédure invasive programmée** (élective). Complète la fiche déjà construite dans ce site pour la procédure invasive **non programmée** / l'hémorragie (document distinct, même groupe de travail).

Méthodologie — distincte de GRADE : ce document ne comporte pas de niveaux GRADE 1+/1-/2+/2-. Les propositions ont été rédigées par cinq groupes de travail du Groupe d'intérêt en hémostase périopératoire (GIHP) et du Groupe français d'études sur l'hémostase et la thrombose (GFHT), en collaboration avec la SFAR, puis soumises à un vote (n = 37) : une proposition est retenue si au moins 50 % des votants expriment leur accord (et moins de 20 % une opinion contraire) ; l'accord est qualifié de « **fort** » si le seuil atteint 70 %. En l'absence d'accord, les propositions étaient reformulées puis resoumises au vote.

Divergence source-interne (disclosure) : le Résumé de la source affirme : « Ces propositions ont été discutées et validées par vote ; *toutes sauf une* ont fait l'objet d'un accord fort. » Une vérification directe, proposition par proposition, de l'intégralité du corps du texte (y compris les propositions associées à la Figure 1 et au Tableau I, vérifiées visuellement sur le rendu de page) montre que **toutes les propositions retrouvées portent explicitement le tag « (accord fort) »**, sans qu'aucune ne porte un tag différent ou plus faible nulle part dans le document. L'exception annoncée par le résumé n'est donc **pas identifiable** dans le corps du texte source — elle n'est pas devinée ici ; les deux constats (l'affirmation du résumé et l'absence de toute proposition tagée autrement que « accord fort » dans le corps du texte) sont disclosés tels quels, sans résolution silencieuse.

Légende (convention de ce document)

Fort

Proposition retenue par vote du groupe de travail GIHP/GFHT (n = 37) avec « accord fort » (≥ 70 % des voix). Seul tag de force imprimé par la source à côté de chaque proposition individuelle du corps du texte (voir encadré ci-dessous).

AAP pour une procédure programmée

Classification du risque hémorragique de la procédure



Classification du risque hémorragique de la procédure

Thème	Proposition	Accord
Principe	Il est proposé de diviser le risque hémorragique associé à la procédure invasive en risque élevé, intermédiaire et faible.	Fort
Risque élevé	Les procédures à risque hémorragique élevé sont définies comme non réalisables sous AAP, même sous aspirine en monothérapie. Ce sont celles pour lesquelles le risque hémorragique sous aspirine est soit inconnu mais considéré comme potentiellement préoccupant, soit inacceptable ou jugé comme tel (risque léthal ou fonctionnel). Elles sont peu fréquentes et incluent, par exemple, certains actes d'urologie lorsque des techniques alternatives ne peuvent pas être utilisées, de nombreux actes de neurochirurgie intracrânienne, les chirurgies avec des délabrements importants ou de grandes dissections, certains actes de chirurgie hépatique ou thoracique.	Fort
Risque intermédiaire	Les procédures à risque hémorragique intermédiaire sont définies comme réalisables sous aspirine seule. Il s'agit de la majorité des procédures invasives.	Fort
Risque faible	Les procédures à faible risque hémorragique sont définies comme réalisables sous bithérapie antiplaquettaire. Elles incluent, par exemple, la chirurgie de la cataracte, certains actes de chirurgie buccodentaire, certains actes d'urologie telle l'uréthrocystoscopie, certains actes de chirurgie vasculaire, certaines bronchoscopies, certains actes d'endoscopie digestive, incluant par exemple, toutes les endoscopies diagnostiques avec ou sans biopsies, les cholangio-pancréatographies rétrogrades endoscopiques sans sphinctérotomie, les polypectomies coliques < 1 cm. Toutefois, l'expérience de ces procédures avec le ticagrelor ou le prasugrel est limitée. De plus, l'administration associée d'autres médicaments interférant avec l'hémostase, ou l'existence d'une comorbidité augmentant le risque hémorragique, peuvent conduire à choisir l'interruption de l'anti-P2Y12.	Fort
Absence de consensus	Lorsqu'il n'existe pas de consensus ou de référentiel pour classer un acte invasif dans une de ces catégories, il est proposé qu'une équipe référente (opérateur, anesthésiste, cardiologue, pneumologue, médecin vasculaire, hémostasien...) dans l'établissement de santé définisse une attitude de prise en charge, au cas par cas, ou pour un profil de patient ou de geste. Ces décisions sont notifiées dans le dossier du patient ou dans les procédures de l'établissement.	Fort
Endoscopies digestives	Concernant les endoscopies digestives, il est proposé que des stratégies de gestion des AAP soient définies dans chaque centre en fonction du profil des patients pris en charge et donc du geste invasif pouvant être potentiellement réalisé pendant l'endoscopie. Ainsi, si la probabilité d'un geste nécessitant une interruption des AAP pour un profil de patient déterminé est jugée élevée, c'est cette stratégie qui est adoptée (ex. : sphinctérotomie, gastrostomie...). En revanche, si la probabilité est faible, c'est la poursuite des AAP qui est privilégiée (ex. : maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, dyspepsie...). Quand la probabilité et la nature des lésions à réséquer n'est pas connue a priori, chaque centre détermine son attitude (ex. : recherche de polypes).	Fort

AAP pour une procédure programmée

Figure 1 — synthèse des propositions & Tableau I



Figure 1 — Synthèse des propositions

Tableau-matrice reproduisant intégralement la Figure 1 du document source (risque hémorragique de la procédure en colonnes, risque thrombotique du patient en lignes).

Risque thrombotique du patient	Risque hémorragique de la procédure (à évaluer avec le chirurgien ou le responsable de la procédure)		
	Faible	Intermédiaire	Élevé
Aspirine en prévention primaire	Arrêt ou poursuite	Arrêt	Arrêt
AAP en prévention secondaire (prévention cardiovasculaire, artériopathie des membres inférieurs, antécédent d'accident vasculaire cérébral ischémique)			
Aspirine en monothérapie	Poursuite	Poursuite	Arrêt
Clopidogrel en monothérapie	Poursuite	Arrêt et relais par aspirine	Arrêt
Bithérapie antiplaquettaire pour stent coronaire (différer la procédure à la fin de la bithérapie antiplaquettaire en l'absence de risque vital ou fonctionnel)			
Stent < 1 mois / stent < 6 mois à haut risque thrombotique* / IDM < 6 mois	Différer la procédure. Si impossible : poursuivre les 2 AAP	Différer la procédure. Si impossible : poursuivre l'aspirine, interrompre l'anti-P2Y12	Différer la procédure. Si impossible : interrompre les 2 AAP**
Aucun des 3 critères ci-dessus	Poursuivre les 2 AAP	Poursuivre l'aspirine, interrompre l'anti-P2Y12	Interrompre les 2 AAP

Risque hémorragique de la procédure

Faible	Intermédiaire	Élevé
Réalisable sous bithérapie antiplaquettaire (ex : cataracte)	Réalisable sous aspirine seule (ex : PTH)	Non réalisable sous AAP (ex : ampullectomie endoscopique)

Délai d'arrêt des AAP — dernière prise à : J-3 pour l'aspirine ; J-5 pour le clopidogrel et le ticagrélor ; J-7 pour le prasugrel (ajouter 2 jours à chaque durée si neurochirurgie intracrânienne). En post-opératoire, reprendre les 2 AAP au plus vite, en fonction du risque hémorragique.

TABLEAU I — Caractéristiques d'un stent à haut risque thrombotique*

Caractéristique
Antécédent de thrombose de stent sous bithérapie antiplaquettaire
Maladie coronaire diffuse en particulier chez le diabétique
Insuffisance rénale chronique (i.e. ClCr < 60 mL/min)
Traitement d'une occlusion coronaire chronique
Stenting de la dernière artère coronaire perméable
Au moins trois stents implantés
Au moins trois lésions traitées
Bifurcation avec deux stents implantés
Longueur totale de stent > 60 mm

* Renvoi de la Figure 1 et du Tableau I. ** Si stent < 1 mois, discuter un relais par AAP injectable.

AAP pour une procédure programmée

Durées d'interruption, relais & gestion selon l'indication



Durées d'interruption des AAP et relais

Thème	Proposition	Accord
Durées d'interruption	Si l'interruption des AAP avant une procédure invasive est indiquée, il est proposé de les interrompre de la façon suivante : dernière prise d'aspirine à J-3 (J0 correspond au jour de la procédure) ; dernière prise de clopidogrel et de ticagrélor à J-5 ; dernière prise de prasugrel à J-7.	Fort
Relais	Il est recommandé de n'utiliser ni les héparines (HNF ou HBPM) ni les AINS en relais des AAP.	Fort
Aspirine — posologie	Chez les patients traités au long cours par aspirine à des posologies allant jusqu'à 300 mg/j, il est proposé de ne pas réduire la posologie en vue de la chirurgie.	Fort

Note (neurochirurgie intracrânienne) : pour la neurochirurgie intracrânienne, il est proposé que la dernière prise soit à J-5 pour l'aspirine, J-7 pour le clopidogrel et le ticagrélor, J-9 pour le prasugrel (accord fort).

Note (ticagrélor, pontage semi-urgent) : des données récentes suggèrent que la chirurgie semi-urgente de pontage aortocoronaire puisse être réalisée après une interruption plus courte du ticagrélor, de trois à cinq jours, sans surrisque hémorragique pour la majorité des patients. Cependant, dans cette situation, les patients n'ayant pas une correction de l'inhibition plaquettaire induite par le ticagrélor sont exposés à un risque accru d'hémorragie.

Gestion des AAP en fonction de leur indication

Thème	Proposition	Accord
Prévention primaire — non-initiation	Il est proposé de ne pas initier un traitement par aspirine en préopératoire d'une chirurgie non cardiaque (à l'exception de l'endartériectomie carotidienne) dans le but de réduire les événements cardiovasculaires périopératoires.	Fort
Prévention primaire — arrêt	Il est proposé d'arrêter l'aspirine en préopératoire lorsqu'elle est prescrite en prévention primaire.	Fort
Prévention secondaire — poursuite	Il est proposé de ne pas arrêter l'aspirine en préopératoire lorsqu'elle est prescrite en prévention cardiovasculaire secondaire (post-accident vasculaire cérébral ischémique, coronaropathie, artériopathie des membres inférieurs), à l'exception des procédures à risque hémorragique élevé.	Fort
Anti-P2Y12 monothérapie — relais aspirine	Il est proposé que chez les patients traités par un anti-P2Y12 en monothérapie et programmés pour une chirurgie à risque intermédiaire, l'AAP soit remplacé par de l'aspirine, à la dose journalière 75 à 100 mg. Ce changement pourrait avoir lieu plus de sept jours avant la chirurgie, afin de permettre une correction complète de l'inhibition plaquettaire induite par l'anti-P2Y12.	Fort
Reprise postopératoire	Il est proposé que la reprise de l'AAP soit aussi précoce que possible, en fonction du risque de saignement postopératoire, chez les patients ayant une indication à un traitement par AAP en monothérapie au long cours.	Fort

AAP pour une procédure programmée

Bithérapie antiplaquettaire — stent coronaire



Bithérapie antiplaquettaire chez le patient porteur de stent coronaire

Thème	Proposition	Accord
Décision multidisciplinaire	Il est proposé que la gestion préopératoire des AAP et leur reprise postopératoire soit discutée avec le cardiologue du patient ou un cardiologue référent et tracée dans le dossier lorsqu'il s'agit d'une procédure à risque hémorragique intermédiaire ou élevé.	Fort
Report de la chirurgie	Il est proposé de reporter toute chirurgie non cardiaque à la fin de la durée recommandée de la bithérapie antiplaquettaire quand cela ne génère pas de risque vital ou fonctionnel majeur pour le patient.	Fort
Si report impossible	Si ce report n'est pas possible, il est proposé de repousser toute chirurgie non cardiaque au-delà du 1er mois qui suit la pose de stent, quel que soit le type de stent, quelle que soit l'indication (IDM ou coronaropathie stable). Si le geste ne peut être différé au-delà du 1er mois, il est proposé de réaliser cette chirurgie en poursuivant l'aspirine et dans un centre ayant un plateau de cardiologie interventionnelle actif 24 heures sur 24.	Fort
Haut risque thrombotique / IDM	Chez les patients sous bithérapie antiplaquettaire dans les suites d'un IDM ou en cas de pose de stent associé à des caractéristiques à haut risque thrombotique, il est proposé de reporter toute chirurgie non cardiaque au-delà du 6e mois qui suit la pose de stent.	Fort
Aspirine — poursuite	Il est recommandé de poursuivre l'aspirine en préopératoire. Si elle a été interrompue, il est recommandé de la reprendre aussi précocement que possible après la procédure invasive, au mieux le jour même, en fonction du risque de saignement postopératoire.	Fort
Relais parentéral (cas exceptionnels)	Si les deux AAP doivent être interrompus dans le 1er mois suivant la pose de stent, un relais par des AAP parentéraux réversibles comme le tirofiban ou le cangrélol peut être discuté au cas par cas, avec une approche multidisciplinaire (utilisation hors AMM). Dans ces situations exceptionnelles, associées à un haut risque hémorragique et thrombotique, le relais doit être réalisé en soins intensifs et la chirurgie doit être réalisée dans un centre ayant un service de cardiologie interventionnelle actif 24 heures sur 24.	Fort
Reprise des anti-P2Y12	Si les anti-P2Y12 ont été interrompus avant la chirurgie, ils doivent être repris précocement, au mieux dans les 24 à 72 heures après la chirurgie, compte tenu de l'augmentation du risque thrombotique. La reprise se fait avec le même anti-P2Y12 qu'en préopératoire.	Fort
AINS	Il est proposé de ne pas administrer d'AINS en périopératoire chez les patients traités par bithérapie antiplaquettaire.	Fort

Absence de proposition — concernant le recours, ou non, à une dose de charge lors de la reprise des anti-P2Y12 après leur interruption préopératoire, aucune proposition ne peut être faite.

Note (AINS) : l'utilisation périopératoire des coxibs reste possible.

AAP pour une procédure programmée

Anesthésie locorégionale (rachidienne & blocs périphériques)



Anesthésie locorégionale rachidienne (ALR-R)

Thème	Proposition	Accord
Aspirine	L'aspirine ne contre-indique pas une ALR rachidienne si le rapport bénéfice-risque est favorable, en vérifiant l'absence d'anomalie associée de l'hémostase, incluant un traitement anticoagulant. Il est proposé de préférer si possible la rachianesthésie en ponction unique à la péridurale.	Fort
Anti-P2Y12	L'ALR rachidienne est contre-indiquée en cas de traitement par anti-P2Y12 (clopidogrel, prasugrel, ticagrélor), sauf si ces AAP ont été interrompus respectivement 5, 7 et 5 jours avant le geste.	Fort
Cathéter péridural	La mise en place d'un cathéter péridural expose à une gestion complexe des AAP. Le retrait du cathéter suit les mêmes règles que la pose. Le recours au cathéter péridural ne doit pas compromettre la reprise postopératoire des AAP, et en particulier des anti-P2Y12.	Fort

Blocs nerveux périphériques

Blocs à faible risque hémorragique (saignement facilement contrôlable, zone compressible) : blocs superficiels — bloc fémoral, bloc axillaire, bloc sciatique au creux poplité, etc.

Blocs à haut risque hémorragique (saignement non compressible ou aux conséquences potentiellement graves) : blocs profonds — bloc infraclaviculaire, bloc sciatique para-sacré, bloc du plexus lombaire postérieur, etc. ; contre-indiqués sous anti-P2Y12.

Thème	Proposition	Accord
Faible risque	Il est proposé que les blocs nerveux périphériques à faible risque hémorragique puissent être réalisés sous AAP, en mono- ou en bithérapie, si le rapport bénéfice/risque est favorable.	Fort
Haut risque	Il est proposé que les blocs nerveux périphériques à haut risque hémorragique puissent être réalisés sous aspirine en monothérapie si le rapport bénéfice/risque est favorable. Ces blocs sont contre-indiqués sous anti-P2Y12 (clopidogrel, prasugrel, ticagrélor), sauf si ces AAP ont été interrompus respectivement 5, 7 et 5 jours avant le geste.	Fort
Échoguidage	Il est proposé que ces blocs (superficiels ou profonds) soient réalisés par échoguidage et par un opérateur expérimenté.	Fort
Cathéter périnerveux	La mise en place d'un cathéter périnerveux ne doit pas compromettre la reprise postopératoire des AAP, et en particulier des anti-P2Y12. Son retrait suit les mêmes règles que la pose.	Fort

AAP pour une procédure programmée

Chirurgie de pontage aortocoronaire & traçabilité



Chirurgie cardiaque de pontage aortocoronaire (PAC)

Thème	Proposition	Accord
Décision multidisciplinaire	Il est proposé que la stratégie de gestion des AAP en vue de pontage aortocoronaire (PAC) soit décidée de façon multidisciplinaire en fonction du risque hémorragique et du risque thrombotique de chaque patient.	Fort
Aspirine	Il est proposé de poursuivre l'aspirine pour la chirurgie de PAC.	Fort
Anti-P2Y12 — durées	Pour les patients traités par bithérapie antiplaquettaire, il est proposé de réaliser les procédures de PAC après interruption des anti-P2Y12, avec dernière prise de clopidogrel et de ticagrélor à J-5 et une dernière prise de prasugrel à J-7.	Fort
Ticagrélor — données récentes	Des données récentes suggèrent que la chirurgie semi-urgente puisse être réalisée après une interruption plus courte du ticagrélor, de 3 à 5 jours, sans surrisque hémorragique pour la majorité des patients. Cependant, dans cette situation, les patients n'ayant pas une correction de l'inhibition plaquettaire induite par le ticagrélor sont exposés à un risque d'hémorragie.	Fort

Sources et traçabilité

Document source : « Gestion des agents antiplaquettaires pour une procédure invasive programmée » — Propositions du Groupe d'intérêt en hémostase périopératoire (GIHP) et du Groupe français d'études sur l'hémostase et la thrombose (GFHT), en collaboration avec la Société française d'anesthésie-réanimation (SFAR). Anne Godier, Pierre Fontana, Serge Motte, Annick Steib, Fanny Bonhomme, Sylvie Schlumberger, Thomas Lecompte, Nadia Rosencher, Sophie Susen, André Vincentelli, Yves Gruel, Pierre Albaladejo, Jean-Philippe Collet, et le French Working Group on perioperative hemostasis (GIHP). Anesth Reanim 2018 (ANREA-314).

Publication : doi 10.1016/j.anrea.2018.01.002.

Méthodologie : pas de système GRADE — propositions rédigées par cinq groupes de travail GIHP/GFHT puis validées par vote (n = 37) ; seuil de 50 % pour retenir une proposition, seuil de 70 % pour un « accord fort » (voir légende page 1 et disclosure sur la divergence source-interne concernant l'unique exception annoncée par le résumé mais non identifiable dans le corps du texte).

Couverture : cette fiche reprend l'intégralité des propositions du corps du texte (classification du risque hémorragique de la procédure, durées d'interruption et relais, gestion selon l'indication, bithérapie pour stent coronaire, anesthésie locorégionale rachidienne et blocs périphériques, chirurgie de pontage aortocoronaire), ainsi que la Figure 1 (synthèse des propositions) et le Tableau I (caractéristiques d'un stent à haut risque thrombotique), reproduits intégralement en tableaux structurés.

Avertissement : ce document est une fiche de synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Il reprend l'intégralité des propositions, de la Figure 1 et du Tableau I du document source, mais ne remplace pas le texte intégral (argumentaire complet, références bibliographiques) et n'est ni édité ni validé par le GIHP, le GFHT ou la SFAR. En cas de doute, se référer au texte intégral et/ou à un avis spécialisé. Document de 2018 : vérifier l'existence d'une actualisation plus récente en cas de doute.